

Морфологические изменения при облитерирующем эндартериите преимущественно развиваются в: {

- ~ адвентиции сосуда
 - ~ мышечном слое сосуда
 - = интима сосуда
 - ~ перивазальной клетчатке
 - ~ нервных элементах, окружающих артерию
- }

Лечебные мероприятия в I стадии облитерирующего эндартериита заключаются в следующем: {

- ~ протезировании сосуда
 - = консервативном медикаментозном лечении
 - ~ эндартериоэктомии
 - ~ шунтировании
 - ~ симпатэктомии
- }

При эмболии бедренной артерии наиболее целесообразной операцией является: {

- ~ резекция пораженного сегмента
 - ~ артобедренное шунтирование
 - ~ симпатэктомия
 - = эмболэктомия
 - ~ шунтирование аутовеной
- }

При нарушениях артериального кровообращения проба Машковича выполняется для определения времени: {

- = наступления гиперемии кожи после снятия ранее наложенного жгута
 - ~ наступления венозного застоя
 - ~ появление мраморного цвета кожи
 - ~ появление петехий кожи
 - ~ появления отека конечности
- }

К тромбоэмболии брыжеечной артерии может привести: {

- ~ тромбоз поверхностных вен
 - ~ инфаркт миокарда
 - ~ варикозная болезнь
 - = стеноз митрального клапана с мерцательной аритмией
 - ~ перитонит
- }

Для выявления заболеваний артерий применяют следующие методы исследования: {

- ~ азонирование
- ~ фистулография
- ~ цистография
- ~ эхография
- ~ ангиография
- }

Прогрессирование влажной гангрены на почве тромбоза магистральной артерии нижней конечности требует выполнения: {

- = срочной ампутации бедра
- ~ шунтирование артерий
- ~ множественных лампасных разрезов
- ~ массивной антибиотиковой терапии
- ~ массивной гемотрансфузии
- }

Одной из частых причин острого тромбоза артерий нижних конечностей является: {

- ~ пункция и катеризация артерий
- облитерирующий эндартериит
- = облитерирующий атеросклероз
- ~ экстравазальная имбибиция артерий
- ~ ушиб мягких тканей в зоне сосудистого пучка нижней конечности
- }

При атеросклеротической окклюзии брюшного отдела аорты наиболее целесообразно выполнить: {

- ~ ретроградное катетеризацию аорты
- = бифуркационное аорто-бедренное шунтирование
- ~ перееартериальную симпатэктомию
- ~ одностороннее аорто-бедренное шунтирование
- ~ поясничную симпатэктомию
- }

Симптомами артериальной эмболии являются: {

- ~ отек конечности
- ~ гиперемия конечности
- ~ появление болезненного инфильтрата
- ~ учащение пульсации сосудов конечности
- = резкая боль и похолодание конечности
- }

Частым источником тромбоза эмболии магистральных артерий нижних конечностей являются: {

- ~ илеофemorальный тромбоз
- ~ синдром нижней полой вены

- ~ катетеризация плечевой артерии
- = мерцательная аритмия, аневризма брюшной аорты, бактериальный эндокардит
- ~ плечелопаточный периартрит

}

Тромбозу периферических артерий конечностей благоприятствуют: {

- ~ болезнь Бюргера
- ~ аневризма сонной артерии
- = облитерирующий атеросклероз и эндартериит, сахарный диабет
- ~ пневмания
- ~ стенокардия напряжения

}

главным патогенетическим фактором в развитии спонтанной гангрены является: {

- = гипердреналинемия
- ~ гиперкажемия
- ~ гиперхолестеринемия
- ~ гиперазотемия
- ~ гипернатриемия

}

В проблеме лечения острой артериальной непроходимости решающую роль играет организация: {

- = срочной специализированной помощи
- ~ диспансерной помощи
- ~ профилактической помощи
- ~ консультативной помощи
- ~ плановой медицинской помощи

}

Различают следующие виды артериальных эмбол: {

- ~ газовая
- ~ жировая
- ~ бактериальная, опухолевая
- ~ тромбом
- ~ верно все

}

К наиболее достоверным методам исследования при острой ишемии конечности относятся: {

- ~ физикальное исследование
- = ангиография, УЗ-доплерография, радионуклеидное исследование

функциональные пробы

- ~ фотометрия
- ~ фистулография

}

Без радикального хирургического вмешательства острая эмболия подколенной артерии может привести к: {

- ~ лимфостазу
- ~ хронической артерно-венозной недостаточности
- = гангрены голени и стопы
- ~ сердечной недостаточности
- ~ слоновости нижней конечности
- }

Развитию облитерирующего эндартериита благоприятствуют: {

- ~ грязелечение
- ~ частые морские купания
- ~ термально-радоновые ванны
- = курение, переохлаждение, отрицательные эмоции
- ~ тяжелый физический труд
- }

Эмболии эндогенного происхождения могут быть вызваны следующими заболеваниями: {

- ~ ревматическими пороками сердца
- ~ инфарктом миокарда
- ~ атеросклеротическим кардиосклерозом с мерцательной аритмией
- ~ язвенным атероматозом аорты
- = верно все
- }

Симптомом перемежающей хромоты означает: {

- = боли в икроножных мышцах голени связанные с прохождением малого расстояния (меньше 1 км)
- ~ ортостатические боли в мышцах конечности и поясницы
- ~ боли и утомляемость в конечностях после прохождения значительного расстояния (более 4-5 км)
- ~ пронизывающие боли по ходу нервных стволов
- ~ периодические боли в нижних конечностях независимо от ходьбы
- }

Первое место среди причин артериальных эмболий занимают: {

- = ревматические пороки сердца с мерцательной аритмией
- ~ дегенеративные (воспалительные) заболевания артерий
- ~ эмболии неясной этиологии
- ~ пороки развития сосудов
- ~ механические повреждения сосудов
- }

При ревматических пороках сердца чаще развивается эмболический инфаркт следующего органа: {

- ~ почек
- ~ селезенки
- ~ миокарда
- = головного мозга, легких
- ~ печени
- }

Синдром Лериша означает атеросклеротическое поражение: {
 = нижнего отрезка брюшной аорты и подвздошных артерий
 ~ бифуркации аорты
 ~ левой подвздошной артерии
 ~ наружной подвздошной и бедренной артерии
 ~ дуги аорты
 }

Классическими симптомами эмболии артерий нижней конечности являются: {
 ~ сильные боли в пораженной конечности
 ~ похолодание и резкая бледность кожных покровов
 ~ нарушение поверхностной и глубокой чувствительности
 ~ нарушение функции
 ~ исчезновение пульсации артерии ниже места обтурации
 = верно все
 }

Симптомами раннего периода функциональных изменений (первые часы эмболии) являются: {
 ~ теплая бледность кожных покровов
 ~ сохранение чувствительности
 ~ сохранение движений
 ~ некоторая ограниченность функции конечности
 = верно все
 }

Для периода органических изменений (через 12-24 часа с момента возникновения эмболии) характерны следующие симптомы: {
 ~ отек мышц
 ~ мышечные контрактуры
 ~ глубокая аноксия тканей (переход мраморной окраски кожных покровов в цианотическую)
 ~ снижение кожной температуры
 ~ анестезия и арефлексия в зоне ишемии
 = верно все
 }

Самой неблагоприятной по локализации является эмболия бифуркации аорты, которой характерны: {

- ~ общее тяжелое состояние
- ~ внезапно появившиеся, крайне интенсивные боли охватывающие нижние отделы живота, поясничную область, промежность, органы таза, конечности
- ~ иногда боли напоминают болевой синдром при перфорации полого органа в брюшной полости
- ~ активные движения в конечностях исчезают уже в первые часы возникновения эмболии
- ~ отмечаются парестезии, гиперестезии и могут возникнуть нарушение функции тазовых органов
- = все верно
- }

При тромбозе брыжеечной артерии наблюдается клиника: {

- ~ внутрибрюшного кровотечения
- ~ сепсиса
- ~ почечной недостаточности
- ~ печеночной недостаточности
- = перитонита
- }

Причинами острой артериальной недостаточности являются: {

- = тромбоз и эмболия
- ~ облитерирующий атеросклероз
- ~ облитерирующий эндартериит
- ~ болезнь Рейно
- ~ болезнь Рейтера
- }

Продольный боковой шов поврежденной артерии не следует применять, если диаметр сосуда меньше: {

- ~ 6мм
- = 4мм
- ~ 5мм
- ~ 8мм
- ~ 7мм
- }

При тромбозе артерий небольшого диаметра предпочтительнее применить следующее оперативное вмешательство: {

- ~ тромбэктомия с помощью зондов снабженных баллончиком
- ~ поясничная симпатэктомия
- ~ интимтромбэктомия
- ~ обходной аутовенозной шунт
- = аутовенозная пластика
- }

Для оказания квалифицированной помощи при острых сосудистых нарушениях должен быть привлечен хирург: {

~ общего профиля

~ абдоминального направления

= ангиологического отделения

~ травматолог

~ любого профиля с многолетним опытом практической работы

}